

TEMA 5.12 • HEMATOLOGÍA

Púrpura

PERFIL EUNACOM 1.07.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Púrpura: Clasificación y Manejo

Definición

Lesiones cutáneas que **no blanquean** con la compresión digital (vitropresión negativa).

- Tipos: petequias (< 3 mm), equimosis (> 3 mm, moretones), vasculitis leucocitoclástica

Algoritmo diagnóstico

''' Púrpura | └─ FEBRIL → **URGENCIA** → hospitalizar | (meningococemia, CID, vasculitis ANCA) | └─ AFEBRIL └─ Hemograma └─ Plaquetas ↓ (trombocitopénica) | └─ PTI (púrpura trombocitopénica inmune) | └─ PTT (púrpura trombótica trombocitopénica) | └─ Leucemia, aplasia, mielodisplasia | └─ Plaquetas normales (no trombocitopénica) └─ Púrpura de Heno-Schönlein (depósito IgA) └─ Vasculitis leucocitoclástica, coagulopatías '''

Púrpura Trombocitopénica Inmune (PTI)

- Mecanismo:** autoanticuerpos anti-plaquetarios (anti-GPIIb/IIIa)
- Clínica:** petequias + plaquetas < 100.000 en hemograma
- Diagnóstico:** hemograma + frotis (plaquetas raras o ausentes) → diagnóstico de exclusión
- Tratamiento:**
 - Plaquetas > 30.000 sin síntomas → solo observar
 - Plaquetas < 30.000 o síntomas → corticoides
 - Refractario → rituximab o esplenectomía

Púrpura de Heno-Schönlein (PHS / IgA)

- Predominio en niños

- Tétrada:** púrpura palpable (miembros inferiores) + artralgia + dolor abdominal + **nefritis por IgA**
- Plaquetas normales** (no es trombocitopénica)
- Tratamiento: soporte; corticoides si afección renal o abdominal grave

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 5 años con lesiones cutáneas en extremidades inferiores que no blanquean a la compresión y fiebre de 39°C. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Púrpura. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La púrpura es la aparición de lesiones que no blanquean con la compresión
- Las lesiones más importantes son petequias y equimosis
- El diagnóstico es absolutamente clínico
- El primer examen a solicitar es el hemograma para evaluar si hay trombocitopenia
- Púrpura trombocitopénica: PTI y otras. Púrpura no trombocitopénica: Schonlein-Henoch
- La púrpura febril es SIEMPRE una urgencia: hospitalizar y estudiar de inmediato
- Causas de púrpura febril: meningococemia, CID, vasculitis ANCA positiva

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PÚRPURA)

PREGUNTA 1

Paciente de 5 años con lesiones cutáneas en extremidades inferiores que no blanquean a la compresión y fiebre de 39°C. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A)** Observar y controlar ambulatoriamente en 48 horas
- B)** Hospitalizar y estudiar de inmediato
- C)** Indicar antihistamínicos y AINEs
- D)** Solicitar biopsia de piel ambulatoria
- E)** Iniciar corticoides orales

PREGUNTA 2

¿Cuál es el primer examen que se debe solicitar ante un paciente con púrpura?

- A)** Biopsia de piel
- B)** Tiempos de coagulación
- C)** Hemograma
- D)** Perfil de hierro
- E)** Prueba de Coombs

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes características define clínicamente a una púrpura?

- A)** Lesiones cutáneas que blanquean con la compresión
- B)** Lesiones cutáneas que no blanquean con la compresión
- C)** Lesiones vesiculares pruriginosas
- D)** Lesiones papulosas descamativas
- E)** Placas eritematosas con borde activo

RESUMEN: PÚRPURA

Esta clase introduce el concepto de púrpura en medicina. La púrpura es la aparición de lesiones que no blanquean con la compresión, siendo las más importantes las petequias y las equimosis. También puede manifestarse como vasculitis leucocitoclástica. El diagnóstico de púrpura es absolutamente clínico, pero el manejo se orienta a identificar y tratar la causa. El primer examen a solicitar es el hemograma para determinar si hay trombocitopenia (PTI, por ejemplo) o no (púrpura de Schonlein-Henoch/púrpura por depósito de IgA). Importante: la púrpura febril es siempre una urgencia médica que requiere hospitalización y estudio inmediato, ya que puede reflejar patologías graves como meningococcemia, CID o vasculitis ANCA positiva.